

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	慢性鼻竇炎 Chronic sinusitis				
編號	A31000-Q03-W-C13	制定者	N10 韓蕎伊	公布日期	111 年 10 月 04 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 11 月 21 日
版本/總頁數	第 1.1 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 02 日

一、目的

讓護理人員了解慢性鼻竇炎的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，增加臨床照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

慢性鼻竇炎指鼻竇炎症狀持續 2-3 個月以上。常因復發或持續性的鼻竇感染，造成鼻竇內側黏膜變厚、鼻黏膜水腫和慢性鼻塞。

（二）症狀

- 1.鼻塞、鼻涕倒流、濃鼻涕。
- 2.鼻部疼痛、顏面脹痛、牙痛、頭痛。
- 3.嗅覺功能異常或喪失。
- 4.咽喉異物感、口臭、咳嗽。
- 5.失眠、容易疲勞。

（三）常見檢查

醫師詳細檢查鼻腔、鼻竇開口及鼻咽部，可輔以鼻竇內視鏡檢查、X 光及電腦斷層掃描來協助診斷。電腦斷層掃描對於慢性鼻竇炎的嚴重度有不錯的診斷價值，常作為手術前評估的重要工具。

主題名稱	慢性鼻竇炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C13	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	2/6

(四) 常見治療

- 1.藥物治療：類固醇鼻內噴劑、口服抗生素、類固醇及抗組織胺、局部類固醇及抗生素鼻腔沖洗。
- 2.手術治療：在藥物治療無效時才考慮手術治療，但黴菌性鼻竇炎患者例外，手術可能為其第一線治療方式。目前主流手術方式為功能性內視鏡鼻竇手術，藉由細小的鼻竇內視鏡放入鼻腔並進入鼻竇中，可直接看到鼻竇內構造，以便切除病變的組織和擴大鼻竇開口，達到重建鼻竇引流和清除黏液，並使鼻竇開口通暢，目的為保留及改善鼻竇口原有的生理功能：通氣與引流。

(五) 護理問題

- 1.易感染/第二道防線不完善-術後傷口。
- 2.呼吸道清除功能不良/鼻腔分泌物增加。
- 3.疼痛不適/與手術後有關。
- 4.尋求(特定的)健康協助/缺乏對疾病資訊之來源。

(六) 護理措施

- 1.易感染/第二道防線不完善-術後傷口
 - (1)監測生命徵象。
 - (2)紀錄及檢查鼻腔內傷口滲出液顏色、氣味、濃稠度。
 - (3)手術後鼻部會有流血情形，鼻孔外部會貼一塊摺疊的紗布以吸取鼻內滲液，若紗布滲濕量佔2/3時即可更換。
 - (4)治療前後洗手。
 - (5)教導感染的危險因子及預防感染的重要性。
 - (6)指導炎症症狀及徵象，如：發燒、眼周紅腫。
 - (7)由於術後張口呼吸會有口腔異味及口乾情形，指導病人多喝水約2000c.c/天。
 - (8)依醫囑按時給予抗生素。
 - (9)保持乾淨的環境。

主題名稱	慢性鼻竇炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C13	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	3/6

2. 呼吸道清除功能不良/鼻腔分泌物增加

- (1) 評估呼吸狀況，紀錄呼吸頻率和節律、呼吸音、咳嗽和分泌物的特性。
- (2) 協助病人採高坐臥姿，眼睛可平視電視，避免平躺，以利引流滲出液，減輕鼻子腫脹及避免噁心嘔吐。
- (3) 術後視情況鼻腔內使用止血棉條填塞止血，約放置3-4天，因此易有鼻塞腫脹不適，可衛教病人採張口呼吸且不可自行將止血棉移除，以免造成出血。
- (4) 依醫囑給予藥物，以減少鼻腔分泌物並評估效果及副作用。

3. 疼痛不適/與手術後有關

- (1) 評估病人的疼痛程度及特徵。
- (2) 評估疼痛加劇的原因。
- (3) 減少或排除疼痛的因素。
- (4) 教導放鬆技巧，如：深呼吸、背部按摩、冥想。
- (5) 予轉移注意力，如：音樂、書籍、聊天。
- (6) 依醫囑予冰敷，每次10-15分鐘，間隔30分鐘，以減緩術後腫脹感疼痛，並收縮血管預防出血。
- (7) 依醫囑給予止痛劑，並評估藥物的效果及副作用。

4. 尋求(特定的)健康協助/缺乏對疾病資訊之來源

- (1) 評估病人及家屬認知及對手術的瞭解程度。
- (2) 告知手術的目的及過程。
- (3) 提供疾病衛教單張並予指導衛教。
- (4) 鼓勵病人發問及解答其疑問。
- (5) 介紹成功病人，減輕其焦慮並給予心理支持。
- (6) 給予手術前、後之衛教及注意事項。
- (7) 衛教若有傷口感染及異常徵兆（紅、腫、熱、痛、滲液多、滲血），請通知護理人員。

主題名稱	慢性鼻竇炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C13	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	4/6

(8)由於術後張口呼吸會有口腔異味及口乾情形，指導病人多喝水約2000c.c/天。

(9)若有任何不適或異常，如：大量鼻出血，請通知護理人員。

(七) 衛教指導

- 1.術後出現視力模糊或眼眶周圍瘀青現象，請立即告知醫護人員。
- 2.術後禁止用力擤鼻子、打噴嚏時口要張開，避免造成出血。
- 3.手術後進食易咀嚼的食物，例如：稀飯、麵食、蒸蛋及魚肉，禁止熱湯、熱食、菸酒、辛辣物、咖啡及油炸物，以防止對鼻黏膜造成刺激及出血。
- 4.由於術後張口呼吸導致口腔分泌物增加，因此需多喝水及嗽口，保持口腔清潔。
- 5.術後一個月避免進行劇烈運動、提重物及擤鼻涕，避免傷口出血。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 王凌風、戴志峰(2022)・手術適應症與術前準備・台灣耳鼻喉頭頸外科雜誌，56・18-21。
- (二) 李和惠等(2019)・眼耳鼻喉疾病病人之護理・於胡月娟總校閱，內外科護理學下冊(1050-1064 頁)，華杏。
- (三) Richard R Orlandi et al. International consensus statement on allergy and rhinology: rhinosinusitis 2021. Int Forum Allergy Rhinol. 2021Mar;11(3):213-739.

主題名稱	慢性鼻竇炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C13	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	5/6

七、附件

(略)

主題名稱	慢性鼻竇炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C13	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	6/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
111.10.04	1.0	新制定。	111 年 09 月 14 日護理長會議通過；111 年 10 月 04 日督導會議通過公布。
112.11.21	1.1	1. 第三項第五目之 4.說明內容修正。 2. 第三項第六目之 4.說明內容修正。 2. 第六項參考資料更新。	112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過；112 年 11 月 08 日護理長會議通過；112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。
113.10.15	1.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.02	1.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	